

C

隣接臓器合併切除

combined resection of adjacent organs

到達目標

- 肺癌，縦隔腫瘍において隣接臓器合併切除の対象となる臓器，および頻度を説明できる
- 隣接臓器合併切除でも頻度の高い胸壁合併切除術（肺尖部胸壁浸潤肺癌を含む）を説明できる

1 隣接臓器合併切除の対象

肺癌および悪性縦隔腫瘍では腫瘍の浸潤により隣接臓器の合併切除が必要となる。肺癌取り扱い規約¹⁾では胸壁，壁側胸膜，横隔神経，心膜，奇静脈，胸部神経根（T1，T2 など）または星状神経節への浸潤は T3，縦隔，胸腺，気管，気管分岐部，反回神経，迷走神経，食道，横隔膜，心臓，大血管，椎体，腕神経叢な

どへの浸潤は T4 に分類されている。日本胸部外科学会による 2021 年 1 年間に施行された呼吸器外科手術症例の集計²⁾でも肺癌手術症例における隣接臓器合併切除 558 例中，胸壁が 279 例と最も多く，次いで肺動脈 105 例，心膜 65 例，横隔膜 52 例，上大静脈 22 例，左房 9 例，椎骨 9 例，大動脈 7 例となっている。同集計による縦隔腫瘍手術症例における合併切除 1,058 例では肺が 457 例と最も多く，次いで心膜 357 例，腕頭静脈 111 例，上大静脈 58 例，横隔膜 40 例であった。

2 主な合併切除臓器別の術式

a 胸壁

肺癌の胸壁浸潤は，①第 2 肋骨およびこれより頭側

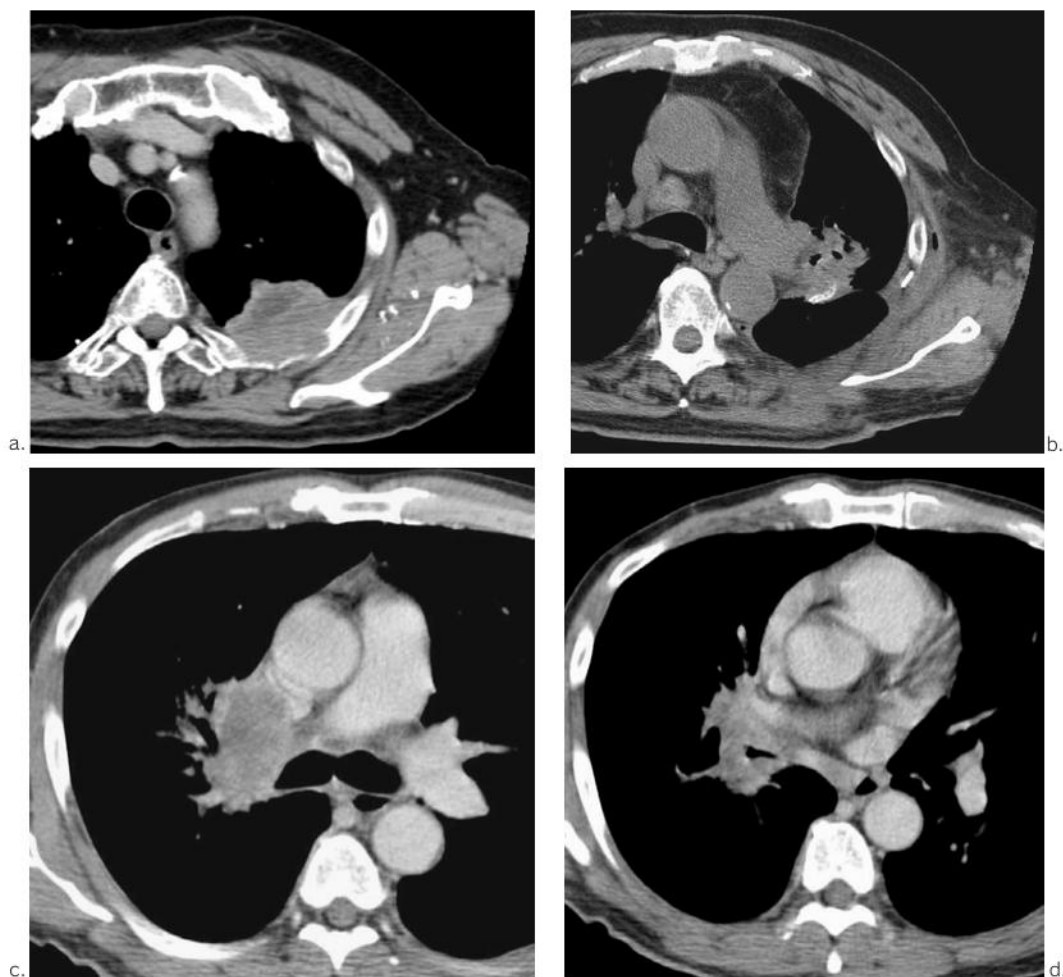


図 1 隣接臓器合併切除症例の胸部 CT

a：胸壁浸潤肺癌（術前），b：aの術後（肩甲骨に隠れる部分での胸壁再建は必要ない場合が多い），c：上大静脈浸潤肺癌，d：心膜浸潤肺癌（cと同一症例）